

56 años

y murió a la espera de una cama en el hospital de
Antofagasta.

Un paciente llega a urgencias. El médico determina que necesita una cama UCI. Desde ese segundo hay dos problemas distintos.

PROBLEMA 1 · CLÍNICO

Estabilizarlo y decidir qué necesita.

Esta decisión ya está tomada por el equipo clínico.

PROBLEMA 2 · OPERACIONAL

Encontrar dónde puede continuar su atención.

Para esto, la decisión clínica tiene que convertirse en información utilizable por toda la red.

La información existe desde el primer minuto. Lo que demora es convertirla en dato.

ATENCIÓN CLÍNICA

“Requiere UCI”

La decisión se toma y se dice en voz alta.

FRICCIÓN

transcripción
digitación
llamadas
verificación

GESTIÓN DE LA RED

Demanda y capacidad

Recibe una foto que puede llegar incompleta o tarde.

Chile ya tiene una infraestructura nacional de gestión de casos. El problema no es esa infraestructura: es **lo que llega hasta ella.**

UGCC · MINSAL

- Alcance nacional, coordina la red asistencial y sus Servicios de Salud.
- Vincula demanda insatisfecha con capacidad disponible.
- Depende de la información que los hospitales reportan.

DESAFÍOS DOCUMENTADOS

Integración entre sistemas.

Avanzar desde “gestión de camas” hacia **gestión de pacientes**.

FUENTES: MINSAL · INFORME UGCC 2014-2017

*“Pasa mucho que hay hospitales que suben a la plataforma a todos sus pacientes hospitalizados en la Urgencia, pero hay otros, como el San José o el Padre Hurtado, que **suben a 7 de los 30 o 40** que tienen hospitalizados”*

(E. Villavicencio, La Tercera)



SIRENA

Capturamos la decisión clínica **en el momento en que se dice** , y la convertimos en información operacional validada.





01 Móvil del profesional

SIRENA

URGENCIA ADULTOS

TRANSCRIPCIÓN EN VIVO

Presione MICRÓFONO y dicte el registro del paciente, o use una frase de respaldo.

EXTRACCIÓN ESTRUCTURADA

Hospitalización

✓ requerida

EJEMPLO · 0.96

Adulto · insuficiencia

✓ respiratoria

EJEMPLO · 0.93

CONFIRMAR

02 Consola web del hospital

Hospital A · urgencia

EN VIVO

UCI EFECTIVAS

1

ESPERANDO UCI

1

BALANCE

0

ÚLTIMOS INGRESOS · TRANSCRIPCIÓN

PACIENTE 1

13:48

PUBLICADO

“Paciente en cama 4-12 con evolución favorable. Se confirma alta médica para hoy.”

PACIENTE 2

13:35

SIN CONFIRMAR

“Probablemente requiera UCI si empeora. No requiere ventilación mecánica.”

03 Vista de administrador · red

Red asistencial

DATOS SINTÉTICOS

Hospital A

DEM 1 · CAP 1

0

Hospital B

DEM 1 · CAP 4

+3

Hospital C

DEM 2 · CAP 2

0

A

DÉFICIT

12 KM

~18 MIN

B

CAPACIDAD

ANTES

Decisión clínica

↓ transcripción y digitación

↓ llamadas y verificación

La red se entera después

DESPUÉS

Decisión clínica dicha una vez

↓ IA estructura certeza y condición

↓ el profesional confirma

La red comparte la misma foto

QUÉ MEDIRÍAMOS EN UN PILOTO

- Tiempo desde decisión clínica a dato estructurado
- Sensibilidad en eventos críticos

- Porcentaje de pacientes capturados
- Minutos de digitación evitados por turno

LO QUE NO PROMETEMOS

- No creamos camas.
- No reemplazamos decisiones médicas.
- No afirmamos cifras que no hayamos medido.

La red no debería enterarse después. Debería enterarse al mismo tiempo que el médico.
